

TEMA 5.22 • OFTALMOLOGÍA

oftalmología pediátrica

PERFIL EUNACOM 6.02.2.009

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Parálisis Oculomotoras y Pupilas Patológicas Sistémicas EUNACOM

Patologías Basales del Tronco Craneal Nervioso de los Pares Oculares III, IV y VI

- **Parálisis Crítica del Oculomotor / Tercer Par Craneal (III Par)**
- - Funciones Bases Vitales Biológicas de inervación motriz ocular: Levanta el párpado superior base y tracciona biótico esfínter miosis central de base. Dirige mirada en tracción base Superior, base Inferior, y Nasal / Medial.
- - **Clínica de la Parálisis Masiva Unilateral:** El paciente cursa dramáticamente con base inicial patética **1. Ptosis perimetral Palpebral Severa, 2. Midriasis General No fotoreactiva fija e inmódificable y 3. Estrabismo base paralítico Severo y base Divergente abducente en base exterior del ojo** (debido perimetralmente general a que el nervio VI indemne general opuesto arrastra sin contraposición el globo al exterior hacia externo base oreja sin resistencia contralateral nasal motora opuesta base).
- - Etiologías EUNACOM Patognomónicas: Las complicaciones neuropáticas isquémicas profundas y desastrosas secas perimetrales más predominantes base microvasculares bióticas letales resultan originadas basales comúnmente a nivel poblacional en las **Complicaciones agudas de la Diabetes mal manejadas.** Alertas: Aneurismas de comunicante posterior cerebral urgentes.
- **Parálisis Focalizada de Aislamiento base del Troclear / Cuarto Par Craneal (IV Par)**
- - Acción base motora biótica muscular innervando y base activando al músculo general puramente oblicuo propio Superior mayor, deprimiendo el ojo cruzado abajo e inferonasal perimetralmente (ej: acción requerida para bajar escaños base en de mirar escaleras escalones cruzadas perimetrales e inferomediales).
- - Parálisis base: Discreta perimetral incapacidad limitante funcional basal generalizada para hundir mirada medial de bajo. Compensando en ligero base visual Estrabismo general perimetral asimétrico elevado y discretamente divergente por reajuste.
- **Parálisis Severa Motora base Abducens / Sexto Par (VI Par Nervio Abducens)**
- - Única acción motora contráctil de estirón base innervando Músculo puro externo simple Recto Lateral biótico base visual cruzando al ojo al costado extremo de lateral abducción.
- - Parálisis Cursa base general con imposibilidad perimetral y basal y restricción física de desviar el globo estático hacia afueras ipsilaterales (orejas bases) lo que por contraposición pura del III tracciona crasamente natural resultando un muy notorio y bizco patológico perimetral **Estrabismo puramente Convergente Nasal crónico base generalizado.**
- **Síndrome Neuromotor base Internuclear (Lesión Fascículo Longitudinal Medial Pura Base General)**
- - Este tracto neuronal del tallo encefálico enlaza las acciones opuestas conjugadas visualmente de mirar hacia de lado paralelamente del VI Par (con núcleo pontino en abducción) frente simétricamente uniendo las raíces contralaterales mesencefálicas de la raíz Oculomotora III de la aducción.
- - Clínica Base del daño de fibra de tracto: Provoca severa discordinación basal general al intencionar mover ambos focos la mirada conjugada lateral, un ojo logrará desviar traccionando el movimiento sin resistencia temporal pero la señal aferente no cursa para que el opuesto contralateral lo asimile medial de la misma forma provocando **Parálisis y pausa basal restrictiva masiva general aductora medial** junto y gatillando sacudidas de alerta perimetral en resorte tipo **Nistagmo de rebote masivo abductor** perimetral. Patrón

fuertemente clásico sospechoso temprano autoinmune esclerótico en base general de EM.

Síndromes Neuro-Pupilares Distintivos y Pupilas Complejas Sistémicas Clínicas

- **Síndrome Disautonómico Craneal Simpático de Síndrome de Claude Bernard-Horner:**
- - Lesión y anulación del tronco de la delicada base ganglionar periférica de cadena estrellada simpática supresora cervical y cérvico perimetral apical. Resultando en clínica y la famosa y triste **Tríada Clásica Base del Síndrome: Ptosis biótica unilateral palpebral discreta, Miosis reactiva pupilar general perimetral (al revés sin midriasis basal pupilo al tercer nervio) e inhabilitante basal focal Anhidrosis base hemicraneal en la piel frontal (sin sudoración mitad superior hemifaz facial).**
- - **Bandera Roja EUNACOM:** Todo diagnóstico primario clínico de un novedoso Horner unilateral biótico focal general adquirido impone y excluye a general urgencia obligatoriamente mediante base imagenológica profunda protocolar el letal oculto descartar tumores perimetrales masivos pulmonares bióticos superiores que carcomen cadenas pélvicas apicales vasculares de pleuras (Clásico y nefasto originado general por base el **Cáncer Epidermoide pulmonar del Vértice o Tumor Pancoast crásico basal**).
- **Pupila de Argyll Robertson (Pupila Asimétrica Irregular Base Neurosifilítica Falsa):**
- - Famosa perimetralidad neurológica en desconexión refleja de disociación lumi-acomodatoria EUNACOM. Curzan estructural biótica base y de perfil neurológico pasmas al foco luminoso **ausencias del básico Reflejo basal base fotomotor en la de pupilas contraíbles mióticas**, pero lográndose sí mantener reactivo reflejo basal miótico per se de contrapeso **conservándose de base biótica acomodativa o reacción y miosis puramente para contracción final la mirar o lectura general y acomodación final focal de corta y próxima distancia.** Manifestación y secuela crónica neurológica tardía puramente confirmatoria a la terrible demencia prefrontal de espiroqueta oculta la generalizada y crónica base luética **Neurosifilis de cordón base Lúes terciario (Trepode puramente Treponémico Palidum crónico cerebral)** (Exigiendo LCR para prueba base puncional profunda VDRL de confirmación obligatoria invasiva neurológica basal).
- **Lagoftalmos Físico Motor Facial Perimetral:**
- - Incapacidad puramente de base en imposibilidad y clausura estructural por esfínter ocular al cierre general muscular mecánico concéntrico biótico estático perimetral basal voluntario pleno fisiológico protector base de cobertura para el mismo propio de los márgenes párpados por estancamiento neuromotor puro inactivo biótico al gran compromiso de daño VII perimetral general del (Nervio Frontal Parálisis general base del Nervio Facial o **Parálisis de Bell**). Resulta la causa base predominante EUNACOM en de etiologías perimetrales severas oculares externas exógenas como base secuela focal secundaria a grave úlcera por base Síndrome desecamiento grave expuesto de Ojo Seco expuesto (Requiriendo imperativo uso base perimétricos vitalicias unciones de colirio pomada lubricativa espesa parche perimetral constante basal a cada rato u oftalmólogo parche nocturno profiláctico ciego de por tiempo y bases resoluciones).

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM**ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:**

"Un niño de seis años tiene agudeza visual de veinte sobre veinte en el ojo izquierdo y de veinte sobre doscientos en el ojo derecho. Al corregir con lentes, el ojo izquierdo mejora a veinte sobre veinte pero el ojo derecho sigue con veinte sobre doscientos. Se confirma miopía de menos seis dioptrías en el ojo derecho y de menos dos dioptrías en el ojo izquierdo. ¿Cuál es el diagnóstico?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para oftalmología pediátrica. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- La ambliopía es la disminución de agudeza visual que persiste después de corregir la causa, por falta de desarrollo neurológico visual durante el período crítico hasta los siete años.
- Las causas principales de ambliopía son anisometrópica (diferencia mayor de tres dioptrías entre ojos) y estrábica (supresión del ojo desviado).
- El tratamiento de la ambliopía es tratar la causa precozmente, antes de los siete años; después de esa edad la recuperación es escasa o nula.
- El estrabismo se diagnostica con la prueba de Hirschberg: el reflejo corneal debe estar en la misma posición en ambos ojos al iluminar desde la distancia.
- Se debe derivar al oftalmólogo cuando el estrabismo es fijo o constante desde cualquier edad, tiene más de seis meses de evolución, o el cover test está alterado.
- El estrabismo madurativo o fisiológico de los primeros meses es normal y puede observarse; la exotropía intermitente es la causa más frecuente en niños mayores.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (OFTALMOLOGÍA PEDIÁTRICA)**PREGUNTA 1**

Un niño de seis años tiene agudeza visual de veinte sobre veinte en el ojo izquierdo y de veinte sobre doscientos en el ojo derecho. Al corregir con lentes, el ojo izquierdo mejora a veinte sobre veinte pero el ojo derecho sigue con veinte sobre doscientos. Se confirma miopía de menos seis dioptrías en el ojo derecho y de menos dos dioptrías en el ojo izquierdo. ¿Cuál es el diagnóstico?

- A)** Miopía severa bilateral que no corrige completamente con lentes
- B)** Ambliopía anisometrópica del ojo derecho
- C)** Glaucoma congénito del ojo derecho con atrofia óptica
- D)** Cataratas unilaterales en el ojo derecho
- E)** Neuritis óptica derecha en contexto pediátrico

PREGUNTA 2

Un lactante de tres meses llega a control sano. La madre nota que el ojo izquierdo a veces parece desviarse hacia adentro. Al examen la prueba de Hirschberg muestra el reflejo corneal en la misma posición en ambos ojos en ese momento. El examen solo revela pliegues epicánticos anchos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y la conducta?

- A)** Endotropía verdadera; derivación urgente al oftalmólogo
- B)** Pseudostrabismo por epicanto; observación y educación a los padres
- C)** Estrabismo madurativo fisiológico; derivar a los seis meses si persiste
- D)** Parálisis del nervio abducente izquierdo; resonancia magnética urgente
- E)** Ambliopía estrábica del ojo izquierdo; ocluir el ojo derecho inmediatamente

PREGUNTA 3

Un niño de cinco años tiene exotropía intermitente: el ojo se va hacia afuera cuando está muy cansado o mirando de lejos. La agudeza visual es veinte sobre veinte bilateral. El estrabismo lleva más de seis meses. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- A)** Observar sin derivar porque la agudeza visual es normal
- B)** Ocluir el ojo izquierdo durante cuatro horas diarias
- C)** Derivar al oftalmólogo porque lleva más de seis meses de evolución
- D)** Indicar lentes para corrección del estrabismo sin derivar
- E)** Tranquilizar a los padres, es un hallazgo normal sin importancia clínica

RESUMEN: OFTALMOLOGÍA PEDIÁTRICA

La oftalmología pediátrica abarca patologías propias de la infancia que requieren diagnóstico y manejo temprano. Esta clase se enfoca en la ambliopía y el estrabismo, que son dos entidades relacionadas y de gran importancia preventiva. La ambliopía es la disminución de la agudeza visual que persiste después de corregir la causa que la originó, en el contexto de un niño en desarrollo. Se produce porque la falta de estimulación visual de uno o ambos ojos durante el período crítico de desarrollo neurológico, habitualmente hasta los siete años de edad, lleva a que no se desarrollen adecuadamente los circuitos neuronales visuales en el cerebro. Las causas principales son la ambliopía anisométrica, que se produce cuando hay diferencia mayor de tres dioptrías entre un ojo y el otro, y la ambliopía estrábica, donde el cerebro suprime la imagen del ojo desviado para evitar la diplopía. El tratamiento es tratar la causa lo más precozmente posible, antes de los siete años para tener posibilidad de recuperación completa. El estrabismo es la desviación de un ojo respecto al eje visual. Puede ser convergente, llamado endotropía, o divergente, llamado exotropía. El diagnóstico se hace con la prueba de Hirschberg, en que se ilumina los ojos desde la distancia y el reflejo corneal debe estar en la misma posición en ambos ojos. El cover test complementa el diagnóstico. Las indicaciones de derivación urgente al oftalmólogo son: estrabismo fijo o constante desde cualquier edad, estrabismo de más de seis meses de duración aunque sea intermitente, y cover test alterado. El estrabismo madurativo o fisiológico de los primeros meses de vida es normal y se puede observar. La exotropía intermitente es la causa más frecuente de estrabismo en niños mayores y tiene buen pronóstico relativo.